



АВТОШКОЛА
EASY DRIVE

**ТЕМА 27. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Любая первая помощь пострадавшим в наше время предполагает, что вы как можно быстрее дозвонитесь до «Скорой помощи». Только делать это надо не сумбурно, к разговору с диспетчером нужно подготовиться. И кому-то из вас на экзамене в ГИБДД обязательно достанется такой вопрос: «Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при ДТП?»

Для того чтобы «Скорая помощь» приехала как можно быстрее, приготовьтесь дать диспетчеру чёткие и ясные ответы на следующие вопросы:

1. Точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП).
2. Кроме того, диспетчеру нужно понимать, сколько машин «Скорой помощи» необходимо отправить. А для этого ему нужно знать точное количество пострадавших, их пол и примерный возраст (ребенок, подросток, взрослый, молодой, среднего возраста, пожилой).
3. А для определения специализации бригады «Скорой помощи» диспетчеру необходима ещё и информация о наличии или отсутствии у пострадавших признаков жизни (сознания, дыхания, кровообращения), а также сильного кровотечения, переломов и других травм.

То есть не следует сразу хвататься за телефон! Не теряя времени, надо осмотреть потерпевших, понять, сколько их, какого они пола, оценить приблизительный возраст и в каком они состоянии (в сознании, без сознания, подают ли хоть какие-нибудь признаки жизни, есть ли у кого-нибудь сильное кровотечение). В противном случае вы только будете бестолково сердиться на диспетчера, задающего, по вашему мнению, какие-то глупые вопросы. И обязательно дождитесь сообщения диспетчера о том, что вызов принят!

Ну, хорошо, до «Скорой» дозвонились, но дальше-то что? Что делать с пострадавшими?

И такой вопрос вам зададут на экзамене. А точнее зададут два вопроса:

1. Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, полученного в результате ДТП?
2. В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?»



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Что должно быть в автомобильной аптечке
с 1 сентября 2024 года



Перчатки медицинские
(размерки не меньше М)
2 пары



Покрывало спасательное
изотермическое
160 × 210 см



Маска медицинская
антисептичная
2 штуки



Жгут кровоостанавливающий
для остановки артериального
кровотечения



Устройство для проведения
искусственного дыхания
«Рот-Устройство-Рот»
2 штуки



Ножницы



Маркер черный/синий
или карандаш



Блокнот



Лейкопластырь
2 × 500 см



Бинты марлевые (размером 5 м
× 10 см – 3 шт, размером 7 м
× 14 см – 3 шт) Или фиксирующие
эластичные бинты



Салфетки стерильные
16x13 см № 10
2 упаковки

В состав автомобильной аптечки входят специальные бактерицидные салфетки, а для сравнительно небольших ран – бактерицидный пластырь. Это новое поколение перевязочных средств, обладающее антимикробным и противовоспалительным действием и не требующее предварительной обработки раневой поверхности. Так что спасибо создателям бактерицидных салфеток.

Пока придет «Скорая помощь», можно, не обрабатывая раны, наложить стерильную салфетку, зафиксировав её пластырем или бинтом. **И ещё!** – в состав аптечки входят медицинские перчатки. Их надо надеть в первую очередь, чтобы защитить себя от заражения инфекциями, передающимися от пострадавшего через кровь.

Если нет прямой опасности для жизни – не извлекайте человека из машины.

В автомобиле пострадавший человек. Все виды помощи, кроме реанимации, можно оказать пострадавшему в автомобиле. А неумелое извлечение и перенос пострадавших может привести к серьезным осложнениям – усилению кровотечения, смещению отломков костей и болевому шоку. Поэтому доставать пострадавшего необходимо, только при высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения потерпевшего, при отсутствии у него сознания и дыхания, а также при невозможности оказания первой помощи непосредственно в салоне автомобиля.

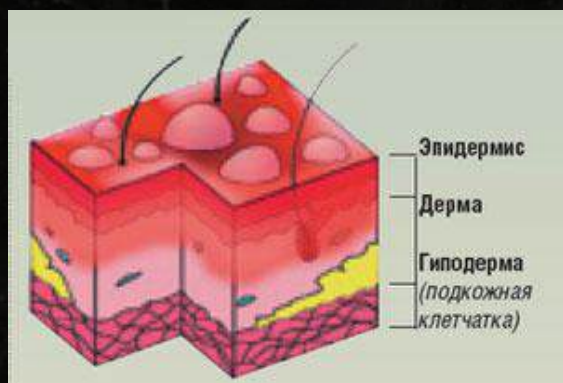
В большинстве случаев перевязать человека или даже наложить жгут выше места ранения, очень даже можно прямо в автомобиле. Если есть подозрение на переломы, накладывать какие-либо шины в тесноте салона будет весьма затруднительно, а к нижним конечностям так и вообще невозможно. Но и в этом случае медики считают, что лучше дождаться их приезда. А пока единственное, что нужно сделать – это остановить кровотечение, если оно есть.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Вот пожар тот случай, когда пострадавших нужно, не раздумывая, извлекать из салона. И по этому поводу в сборнике ГИБДД тоже есть вопрос: **«Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)»?**

Если кожа только лишь покраснела – это ожог первой степени, и тогда порой достаточно просто охладить поражённую поверхность под прохладной проточной водой, **не менее 15-20 минут.**

Но только в том случае, если не нарушена целостность кожного покрова! Если на коже образовались пузыри – это уже, как минимум, ожог второй степени. То есть помимо эпидермиса, воздействию высокой температуры подверглась и сама дерма (собственно кожа).



Необходимо понимать, что в этом случае нельзя применять масляные мази и другие жиросодержащие продукты. Очень распространено заблуждение, что ожог надо смазать чем-то жирным — например, сметаной или растительным маслом.

Подобное недопустимо, такое действие только усугубит тяжесть поражения, а персоналу в больнице придётся удалять масляную плёнку, причиняя дополнительные страдания больному.

Не рекомендуется самостоятельно удалять с пострадавшего фрагменты сгоревшей одежды (данная манипуляция может привести к отслоению больших участков кожи, кровотечению, а впоследствии и к инфицированию раны).

Не располагая навыками и необходимым оснащением, не следует проводить первичную обработку раны самостоятельно. Без обезболивания этот процесс причинит дополнительные страдания больному и может привести к шоку или усугубить его. Также, при обработке раны неизбежно возникнет кровотечение и возрастёт риск инфицирования, если обработка проводится в полевых условиях.

Так что, не будучи врачом и находясь в полевых условиях в ожидании «Скорой помощи», ваша задача – **пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), при возможности приложить холод и поить пострадавшего водой**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

И ещё один момент! Конечно же, человека надо извлекать из автомобиля, если требуется немедленная реанимация, то есть, если в результате осмотра выяснилось, что у него нет пульса на сонной артерии.

А когда вы последний раз проверяли пульс на сонной артерии? Работу сердца определяют по наличию у пострадавшего пульса на сонной артерии **в течение 7-10 секунд.**



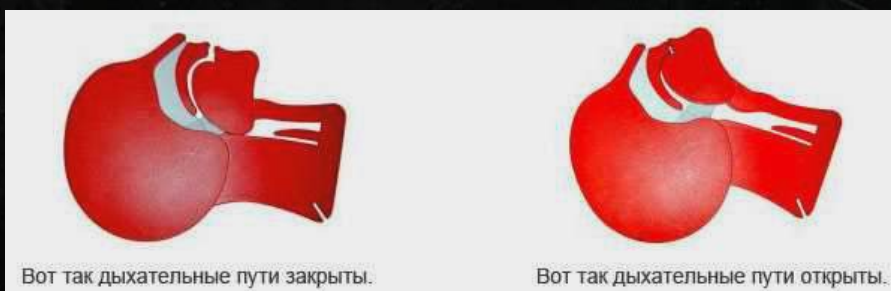
Для того чтобы найти сонную артерию:

1. Поместите средний и указательный пальцы на кадык пострадавшего.
2. Соскользните в сторону до мягкого углубления.
3. Проверьте наличие пульса. (Можете попробовать это прямо сейчас на себе).

Однако МЧС России считает, что простые люди (не врачи) не смогут справиться с такой, казалось бы, несложной процедурой. МЧС России предлагает другую методику, а именно: извлекать человека из салона автомобиля необходимо в том случае, если не похоже, что он вообще дышит.

А когда вы последний раз проверяли наличие дыхания у человека, находящегося без сознания?

Дело в том, что у человека, потерявшего сознание, язык западает в гортань и перекрывает поступление воздуха в дыхательные пути. Поэтому для определения наличия дыхания необходимо сначала восстановить проходимость дыхательных путей пострадавшего.



По методике МЧС (и об этом вас будут спрашивать на Экзамене) для того чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, следует положить одну руку на лоб пострадавшего, а двумя пальцами другой поднять подбородок и запрокинуть голову. При этом пострадавшего надо, конечно же, положить на твердую горизонтальную поверхность.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

И вот теперь можно наклонившись к лицу пострадавшего в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух щекой, установить наличие или отсутствие движения грудной клетки.

Если пострадавший дышит и пульс есть, значит, человек жив, и первую помощь, как уже и говорилось, можно оказывать прямо в автомобиле. Хотя, если следовать методике МЧС, мы из автомобиля его уже извлекли.

Однако если нет пульса на сонной артерии и нет признаков дыхания, **тогда незамедлительно надо приступить к сердечно-лёгочной реанимации**. И времени у нас немного – максимум четыре минуты с момента остановки сердца.

Согласно рекомендации Американской Ассоциации Сердечных Заболеваний правильно проводимый непрямой массаж сердца обеспечивает мозг минимально необходимым количеством кислорода.

А спасение мозга в любой ситуации является наиважнейшим. Поэтому и в России с 2011 г изменен порядок проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Если раньше СЛР принято было начинать с освобождения дыхательных путей, то теперь считается правильным сразу же начать непрямой массаж сердца с последующей искусственной вентиляцией легких, а именно: **30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту»**.



Тут мы должны признаться – всю жизнь считал, что сердце расположено слева.

Но вот в Интернете пишут, что сердце человека располагается в середине грудной клетки. И даже уточняют координаты – за грудиной, на 2 пальца выше ее мечевидного отростка.

При остановке сердца кровообращение можно восстановить, нажимая на грудную клетку. При этом сердце сдавливается между грудиной и позвоночником, а кровь выталкивается из сердца в сосуды. Ритмичные нажатия имитируют сердечные сокращения и восстанавливают кровоток.

Пострадавшего необходимо уложить на спину, на твёрдую поверхность, спасатель располагается сбоку (слева или справа), руки прямые. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в «замок». Руки выпрямляются в локтевых суставах, большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота. Надавливания должны производиться без резких движений.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

После этого уже только реанимация. Ничего другого, только безостановочная реанимация, а именно: 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».

Что касается искусственной вентиляции лёгких методом «Рот ко рту», то об этом хочется поговорить отдельно.

Во всех языках идиома «вдохнуть жизнь в кого-либо» свидетельствует о многовековом опыте такой реанимации. По всей вероятности подобным образом поступил и пророк Елисей, чтобы оживить умершего мальчика: «И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и открыл ребенок глаза свои».

В то же время сегодняшняя статистика происшествий свидетельствует: «Неподготовленный очевидец производит только непрямой массаж сердца до прибытия медиков». Прилагать свои уста к его устам мало кто отваживается. И это понятно. Во-первых, не каждому удаётся преодолеть чувство брезгливости, а, во-вторых, можно элементарно заразиться чем-нибудь от потерпевшего (а вдруг он болен туберкулёзом).

Более того, и прибывшие на место происшествия врачи сегодня тоже не практикуют метод «Рот ко рту». В стандартный комплект реанимобилей должен входить, так называемый, мешок Амбу (устройство для искусственной вентиляции легких). Такое устройство, по сравнению с искусственным дыханием «рот в рот», является не только гигиеничным, но и более эффективным.

Однако «Скорая помощь», какой бы она не была скорой, мгновенно не приедет. А человек на ваших глазах умирает. И если вы всё же решились, тогда необязательно входить в прямой контакт с губами пострадавшего. Для этого достаточно постелить марлевую салфетку. Это, во-первых. А, во-вторых, надо же знать, как это делается.

Что здесь важно – одной рукой разжимаем губы пострадавшего, а другой рукой зажимаем ему нос. Теперь набирайте побольше воздуха и вдыхайте его в пострадавшего. Если всё сделать правильно, должна заметно приподняться его грудная клетка.

Итак, мы определились – пострадавших извлекаем из машины только в случаях, когда **это действительно необходимо**. То есть либо велика вероятность, что автомобиль может опрокинуться, взорваться, загореться (разлит бензин), либо уже горит, либо пострадавшему требуется срочная сердечно-лёгочная реанимация.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Но пострадавшие и сами любят выбираться из автомобиля. При этом в первые минуты после травмы пострадавший заметно возбуждён, уверяет, что всё Окей, отказывается от госпитализации и, вообще, он сейчас пойдёт домой. И если его отпустить, он действительно пойдёт. Только уйдёт недалеко. Через 5-10 минут эректильная фаза шока закончится и начнётся совсем другая фаза – резкий упадок сил. А при тяжелых повреждениях может наступить быстрая смерть.

Спасти пострадавшего может только квалифицированный врач. Поэтому, первым делом надо вызвать «Скорую помощь», а пока она едет, ваша задача – никуда не отпускать пострадавшего, а затем уложить пострадавшего, укрыть, контролировать дыхание и пульс.

И потом на дорогах страдают не только водители и пассажиры, но и пешеходы. И уж они-то точно находятся не в автомобиле. И им тоже надо оказать помощь до приезда «Скорой». И по этому поводу на экзамене в ГИБДД вам зададут бездну вопросов. **Например, такой: «Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании первой помощи»?**

В подавляющем большинстве случаев люди не знают, что делать в такой ситуации – автомобиль сбил пешехода, человек лежит без сознания, но никаких видимых повреждений. Раз нет наружных повреждений, но пострадавший без сознания, значит, есть повреждения внутренних органов. А у человека в бессознательном состоянии западает язык в гортань и перекрывает дыхательные пути. А если есть сотрясение мозга, будет рвота. А если повреждены легкие, во рту может появиться кровь. Сейчас его первым делом нужно повернуть на бок, чтобы он не задохнулся.

И не пытайтесь его поить или давать какие-либо лекарства. Глотательный рефлекс у него сейчас отсутствует! Поэтому вода и таблетки в желудок не попадут! А вот в дыхательные пути попасть очень даже могут. И это, как вы понимаете, не есть хорошо.

Если сердце бьётся (есть пульс на сонной артерии), но пострадавший без сознания, необходимо дожидаться приезда «Скорой помощи».

При этом пострадавшему надо придать так **называемое «восстановительное» положение** – положите его на бок, так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Здесь нам придётся немного задержаться и вот почему. В предыдущей редакции (до 1 сентября 2016 года) этот вопрос в билетах ГИБДД звучал так: «Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства»? И тогда ответ был понятен. Глотательный рефлекс у него сейчас отсутствует, поэтому вода и таблетки в желудок не попадут!

После 1 сентября 2016 года текст вопроса изменился:

? Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

1. Разрешено.
2. Разрешено в случае крайней необходимости.
3. Запрещено.

Как видим, в новой редакции слова «находящемуся в бессознательном состоянии» выпали, но правильный ответ авторы Билетов оставили прежний – «Запрещено». Авторы этой старой (в новом виде) задачи хотят проверить, знаете ли вы, что на территории Российской Федерации действует **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**. И в этом Законе есть **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**.

И в этом Перечне применение лекарственных препаратов при оказании первой помощи не предусмотрено. То есть сегодня до приезда Скорой помощи давать какие-либо лекарственные средства пострадавшим запрещено Законом. И запрещено во всех случаях!

Совсем другое дело, если наблюдается сильное кровотечение. По этому поводу в том же Перечне целый ворох прямых указаний.

Следует знать, что средний объем крови человека – 4,5 литра. Потеря 1/3 объема крови за короткое время обычно приводит к гибели. Кровотечение может быть артериальным и венозным. Артерии — это сосуды, по которым кровь идет от сердца. По венам кровь возвращается в сердце. Артерии расположены глубоко в тканях, за исключением запястья, подъема стопы, виска и шеи. В любом из этих мест прощупывается пульс, по которому врач может получить представление о состоянии артерий. Вены располагаются ближе к поверхности кожи; кровь в них темнее и течет более ровно.

При ранении артерии кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. При оказании первой помощи вначале артерия прижимается пальцами. После чего в точках прижатия выше раны, максимально близко к ней, накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени наложения жгута.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Но почему при этом обязательно требуется зафиксировать время наложения жгута? То есть непосредственно к жгуту надо прикрепить записку с указанием времени наложения жгута.

Более того, профессиональные врачи считают, что лучше написать время наложения жгута прямо на самом жгуте или даже на теле пострадавшего (они боятся, что записка может затеряться, размокнуть и т.д).

Тут дело вот в чём. В отсутствие кровотока во всех нижележащих тканях могут произойти необратимые губительные изменения. А зимой к тому же, если приличный минус, нижняя часть конечности может просто замёрзнуть.



Поэтому зимой максимум через полчаса, а летом максимум через час, необходимо секунд на 10-20 ослабить жгут, чтобы частично восстановить кровоснабжение нижней части конечности (во время ослабления жгута место ранения артерии придётся прижимать пальцами или «пяткой» ладони). А благодаря такой записке прибывшие врачи будут ясно представлять картину происходящего.

Если повреждена вена, тогда жгут накладывать не надо. Понять, что повреждена не артерия, а вена можно по цвету крови – венозная кровь темно-вишневого цвета (в отличие от ярко-алой артериальной). При этом само кровотечение медленное, и чтобы его остановить, достаточно наложить давящую повязку на место ранения.



Вместе с веной могут пострадать и некрупные артерии, но общего подхода это не меняет – достаточно наложить давящую повязку на место ранения.

Ну, и конечно, если дело происходит зимой, пострадавшего нужно согреть.

Только не вздумайте давать ему алкоголь, в результате у него быстро остынет кожный покров. Применяйте самые обычные способы – Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Ещё одна часто встречающаяся травма – переломы.

При закрытых переломах основная задача спасателя – обездвижить место перелома, то есть наложить шины. Но шины, я полагаю, никто с собой не возит, а на месте происшествия не всегда удаётся найти что-нибудь подходящее. В этом случае у спасателя выбор невелик.



Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.



Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке.



При этом лучше не только подвесить её, но ещё и прибинтовать к туловищу.

Следует знать и о таком понятии, как «поза лягушки».



Такую позу непроизвольно занимают пострадавшие с переломом шейки бедра, костей таза, переломом позвоночника, сопровождающиеся повреждением внутренних органов малого таза и внутренним кровотечением.



В этом случае позу менять не надо, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложите под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложите холод.

Ну и, конечно же, во всех ДТП, как правило, страдает голова.

Очень часто ранение волосистой части головы сопровождается кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия. Поэтому в любом случае (сильное кровотечение или слабое) к ране головы необходимо приложить давящую повязку из стерильного бинта. **Необходимо знать, что ушиб головы это почти всегда сотрясение головного мозга.** А сотрясение головного мозга почти всегда сопровождается тошнотой и рвотой. Поэтому, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути пострадавшего, его необходимо уложить на бок с согнутыми в коленях ногами. Если есть возможность раздобыть что-нибудь холодное, приложите его к голове. Это существенно замедлит развитие отека мозга.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

К числу наиболее тяжелых травм относятся повреждения позвоночника. Даже небольшое смещение позвонков может вызвать разрыв спинного мозга, поэтому пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника необходимо очень бережно уложить на ровную твердую поверхность и до приезда «Скорой помощи» вообще никак не перемещать.

И, наконец, ещё одна часто встречающаяся проблема – инородные тела в гортани, затрудняющие дыхание и требующие немедленного извлечения.



Порой для этого достаточно наклонить туловище пострадавшего вперед и ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его между лопатками.



Но если это не помогло, необходимо **использовать более эффективный метод:**

Встать сзади, обхватить пострадавшего обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область живота сцепленными руками в направлении внутрь и кверху.

Делается для того, чтобы создать мощное обратное движение воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани.

Следует помнить о том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено.